

PROMPTS_Gribaa_Ines_CDC.md

Journal de prompts — Phase Conception (CdC)

Étudiante : Inès Gribaa

Partie du CdC couverte : Besoin métier, scénario, utilisateurs, critères d'acceptation, cadre ReEIF & analyse de risques

Projet : IMY-triFHIR — Sujet B (Rendez-vous / calendrier patient, format cible HL7 v2, FHIR R4 4.0.1)

Outil IA utilisé : Claude (Anthropic)

Étape 1 : Analyse du besoin & Scénario Métier

- **Prompt envoyé :**

"Tu es Business Analyst spécialisé dans les systèmes d'information de santé. Nous concevons une application de télé suivi de la maladie de Crohn pour le Sujet B (gestion de calendrier/rendez-vous patient, HAPI FHIR R4). Définis précisément les besoins fonctionnels, les besoins non fonctionnels, le rôle des utilisateurs (patient et médecin) et le contexte métier, puis génère le logigramme bpmn du scénario complet."

- **Réponse de l'IA :**

Besoins fonctionnels

- Réceptionner les réponses du patient au questionnaire de suivi ([QuestionnaireResponse](#)).
- Calculer et consulter le score HBI (*Harvey-Bradshaw Index*) à partir des réponses.
- Proposer automatiquement un rendez-vous si le score HBI est défavorable.
- Permettre au patient de valider ou de refuser la proposition de rendez-vous.
- Transmettre un simple compte-rendu sans création de rendez-vous si le score est favorable.
- Créer puis mettre à jour le rendez-vous validé sous forme de ressource FHIR [Appointment](#).

- Convertir le rendez-vous confirmé au format HL7 v2 (message SIU^S12).

Besoins non fonctionnels

- Connexion directe en REST au serveur
<https://hapi.fhir.org/baseR4> sans persistance locale.
- Traitement des erreurs côté front-end sans interruption ni crash de l'application.
- Journalisation minimaliste des échanges réseau dans la console applicative.

Utilisateurs & Contexte

- **Patient** : Renseigne le questionnaire, consulte la proposition et confirme/refuse le rendez-vous.
- **Médecin gastro-entérologue** : Consulte le score HBI et suit l'état de la planification.
- **Contexte** : Dans le cadre du télésuivi de la maladie de Crohn, une augmentation du score HBI traduit une poussée de la maladie, nécessitant une consultation rapide.

bpmn

Extrait de code

flowchart TD

```

A([Début]) --> B[Réception réponses QuestionnaireResponse]
B --> C[Calcul score HBI DiagnosticReport]
C --> D{Score HBI favorable ?}
D -- Oui --> E[Envoi compte-rendu sans RDV]
E --> Z([Fin])
D -- Non --> F[Proposition de RDV Appointment proposed]
F --> G{RDV validé par le patient ?}
G -- Non --> H[Relance du patient]
H --> G
G -- Oui --> I[Confirmation RDV Appointment booked]
I --> J[Génération message HL7 v2 SIU^S12]
J --> Z

```

Étape 2 : Critères d'acceptation

- **Prompt envoyé :**

"À partir du scénario défini, rédige la liste exacte des 5 critères d'acceptation techniques et fonctionnels indispensables pour valider la prise de rendez-vous et la conversion HL7 v2."

- **Réponse de l'IA :**

1. Le score HBI est calculé/affiché à partir d'une ressource **QuestionnaireResponse** réelle lue sur le serveur FHIR.
2. Un **Appointment** n'est instancié qu'en cas de score HBI défavorable.
3. La proposition de rendez-vous fait l'objet d'un **POST /Appointment** réel sur le serveur avec le statut initial **proposed**.
4. La confirmation du patient déclenche un **PUT /Appointment/{id}** passant le statut à **booked**.
5. La génération du message HL7 v2 **SIU^S12** est conditionnée au succès du passage au statut **booked**.

Étape 3 : Application de la couche Métier du ReEIF

- **Prompt envoyé :**

"Tu es expert ReEIF (module MCLB9). Génère le tableau des jeux de tests (T1 à T5) requis pour valider la couche Métier du cadre ReEIF dans notre projet."

- **Réponse de l'IA :**

#	Cas de test	Entrée / Condition	Résultat attendu
T1	Nominal — score favorable	Score HBI favorable (\$\le 4\$)	Aucun Appointment créé, compte-rendu affiché.
T2	Nominal — score défavorable + validation	Score défavorable (\$\ge 5\$), clic "Valider"	Appointment créé (proposed), mis à jour (booked), message SIU^S12 généré.
T3	RDV proposé mais non validé	Score défavorable, pas de validation	Envoi d'une relance, pas de génération HL7 v2.
T4	Échec — ressource introuvable	Patient / Questionnaire inexistant	Notification d'erreur explicite sans crash.

T5	Échec — erreur réseau lors du PUT	Interruption réseau au moment de valider	Message d'erreur applicatif, annulation de la conversion HL7 v2.
-----------	-----------------------------------	--	--

Étape 4 : Analyse des couches ReEIF & Risques

- **Prompt envoyé :**

"Complète l'analyse ReEIF pour les couches Infrastructure, Application, Information, Organisation et Juridique, puis rédige une note sur le risque lié au serveur public HAPI FHIR."

- **Réponse de l'IA :**

Synthèse des autres couches ReEIF

- **Infrastructure** : Échanges sécurisés en HTTPS via TLS 1.3 vers le serveur HAPI FHIR.
- **Application** : Architecture Web Vue.js 3 effectuant des appels REST/JSON directs sans backend intermédiaire.
- **Information** : Alignement sémantique des identifiants (**Patient.identifier** vers **PID-3**) et des statuts (table HL7 0278).
- **Organisation** : Responsabilité médicale portée par le praticien, validation active par le patient.
- **Juridique** : Traitement de données de santé simulées (fictives) dans un cadre pédagogique conforme au RGPD.

Note d'analyse de risques (Serveur HAPI FHIR)

L'utilisation d'une instance publique mutualisée

([\[https://hapi.fhir.org/baseR4\]](https://hapi.fhir.org/baseR4)(<https://hapi.fhir.org/baseR4>)) présente un risque important de collision de données et d'altération par des tiers. Aucune donnée nominative réelle ne doit y être envoyée. Pour limiter l'impact de ce risque en environnement de test, tous les identifiants créés par l'application doivent impérativement être préfixés par une chaîne unique (**IMY-CROHN-2026-**).